

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE DISCAPACIDAD DE SHEEHAN (SDI / SDS)

Eje IV: Discapacidad y Funcionamiento Global • Escala Analógica Visual de Interferencia Sintomática

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Discapacidad de Sheehan (SDI / Escala SDS).
Nombre Original	Sheehan Disability Scale (SDS; Sheehan, Harnett-Sheehan & Raj, 1996).
Autores Originales	David V. Sheehan, M.D., Kathy Harnett-Sheehan, Ph.D. y B. Ashok Raj, M.D.
Adaptación Hispana	Bobes, González, Bousoño et al. (1999); Universidad de Oviedo / CIBERSAM.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Discapacidad Funcional. Grado de interferencia de los síntomas en roles vitales.
Tipo de Instrumento	Escala visual analógica autoadministrada o heteroaplicada breve (3 dominios + 2 índices).
Formato de Respuesta	Escala numérica de 11 puntos (0 a 10) con anclajes cualitativos de gravedad.
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) en cribado psiquiátrico ambulatorio y ensayos farmacológicos.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos de rápida cumplimentación.
Régimen de Licencia	Propiedad intelectual de D. V. Sheehan; uso clínico y académico bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA DISCAPACIDAD COMO PARÁMETRO DE IMPACTO REAL

La **SDI (Sheehan Disability Scale)** fue formulada en la University of South Florida para evaluar el impacto funcional de la psicopatología:

- Independencia del Diagnóstico Nosológico:** A diferencia de escalas específicas de patología (pánico, fobia social, depresión), la SDI evalúa la **consecuencia invalidante** transversal de cualquier cortejo sintomático sobre los roles esenciales de la vida adulta.
- Diseño Analógico-Visual Discretizado:** La escala de 0 a 10 puntos combina la sensibilidad métrica continua de las escalas analógicas visuales con descriptores verbales operativos en cuatro tramos: Sin alteración (0), Leve (1-3), Moderada (4-6), Marcada (7-9) y Extrema (10).
- Cuantificación de Productividad Perdida:** Incorpora dos reactivos cuantitativos objetivos de días en la última semana: días perdidos por completo (ausentismo) y días con rendimiento mermado (presentismo), permitiendo análisis de farmacoeconomía y salud laboral.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (3 NUCLEARES + 2 MÉTRICOS)

Dominio Funcional	Formato / Rango	Contenido y Criterios Evaluados en el SDI
1. Trabajo / Estudios	Escala 0 a 10 pts	Interferencia de los síntomas en la jornada laboral, tareas profesionales o rendimiento escolar.
2. Vida Social / Ocio	Escala 0 a 10 pts	Limitación de actividades recreativas, salidas con amigos, aficiones y vida comunitaria.
3. Vida Familiar / Hogar	Escala 0 a 10 pts	Interferencia en deberes domésticos, convivencia familiar y cuidado de personas dependientes.
4. Días Perdidos (Ausentismo)	0 a 7 días	Días de la última semana en que el paciente estuvo incapacitado para trabajar o realizar tareas.
5. Días Improductivos	0 a 7 días	Días en que acudió al trabajo o actividades pero con rendimiento claramente disminuido.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación y validación en español (Bobes et al., 1999; $N = 312$ pacientes ambulatorios en salud mental) reporta parámetros psicométricos de alta robustez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.89	Excelente consistencia interna unifactorial en los tres dominios nucleares.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.87 - 0.91	Gran reproducibilidad a 7 y 14 días en pacientes sin variación clínica.
Sensibilidad al Cambio	Efecto $d = 1.28$	Superior a inventarios sintomáticos para captar la respuesta clínica funcional.
Validez Concurrente	$r = 0.75$ (CGI-G)	Fuerte correlación directa con la Impresión Clínica Global de Gravedad.
Convergencia Sintomática	$r = 0.68 - 0.72$	Correlación robusta con escalas de ansiedad (HAM-A) y depresión (HAM-D, MADRS).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Marco Temporal de Referencia:** Interferencia producida durante la última semana (últimos 7 días).
- **Escala de Calificación Nuclear (0 a 10):** 0 = En absoluto; 1 a 3 = Levemente; 4 a 6 = Moderadamente; 7 a 9 = Marcadamente; 10 = Extremadamente / Incapaz.
- **Puntuación Total de Discapacidad SDI:** Se suma el valor numérico de los 3 dominios nucleares:

$$\text{Puntuación Total SDI} = \text{Trabajo} + \text{Vida Social} + \text{Vida Familiar} \quad (\text{Rango: 0 a 30 puntos})$$

- **Índices Complementarios de Productividad:** Se reportan en paralelo como recuento semanal directo:

$$\text{Días Totales de Pérdida Productiva} = \text{Días de Ausentismo} + (0.5 \times \text{Días Improductivos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, **mayor gravedad de la discapacidad funcional** y mayor interferencia sintomática.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

Estratificación	Rango Total	Nivel por Dominio	Significación Clínica y Repercusión Funcional
Sin Discapacidad	0 a 4 pts	0 a 1 pt	Funcionamiento adaptativo normal; síntomas no interfieren en actividades.
Discapacidad Leve	5 a 14 pts	2 a 4 pts	Interferencia perceptible pero compensada; productividad mantenida.
Discapacidad Marcada	15 a 24 pts	5 a 7 pts	Disfunción clara; abandono de ocio; absentismo laboral intermitente.
Colapso Extremo	25 a 30 pts	8 a 10 pts	Incapacidad casi total; aislamiento familiar severo; baja médica prolongada.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS CRÍTICOS (TOTAL ≥ 5 Y TOTAL ≤ 5):

- **Criterio de Cribado Positivo (SDI ≥ 5 o cualquier dominio ≥ 5):** Identifica con 89% de sensibilidad a sujetos con interferencia clínica tributaria de intervención especializada.
- **Criterio de Remisión Funcional Completa (SDI ≤ 5):** Exige una puntuación total menor o igual a 5 puntos junto con ningún dominio individual > 2 y 0 días de ausentismo en la semana previa.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN FUNCIONAL EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y AFECTIVOS

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CON SHEEHAN DISABILITY SCALE:

- **Paso 1 (Línea Base en Consulta de Admisión):** Registrar puntuación en los 3 dominios nucleares y cómputo de días perdidos en la semana previa.
- **Paso 2 (Evaluación de Respuesta a las 4-8 Semanas):** - *Descenso $\geq 50\%$ del SDI total:* Respuesta funcional clínicamente significativa; continuar intervención. - *SDI persiste ≥ 15 con > 2 días perdidos:* Respuesta insuficiente; revisar plan farmacológico o incorporar terapia basada en exposición/activación.
- **Paso 3 (Desconexión Síntoma-Discapacidad):** Si la puntuación del síntoma disminuye pero la SDI familiar/social permanece elevada (≥ 6), abordar patrones de evitación fóbica y acomodación familiar.
- **Paso 4 (Alta Definitiva):** Mantener criterio de remisión funcional ($SDI \leq 5$) durante al menos 12 semanas consecutivas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: RECUPERACIÓN LABORAL EN TRASTORNO DE PÁNICO CON AGORAFOBIA

Identificación: Varón de 32 años, ingeniero informático, diagnosticado de Trastorno de Pánico con Agorafobia severa de 9 meses de evolución. Incapaz de utilizar transporte público o acudir a su oficina, permanece en teletrabajo forzado con crisis paroxísticas diarias.

Evaluación Inicial con SDI:

- **Puntuación Total SDI = 26 / 30 puntos (Colapso Funcional Extremo).** • *Desglose por Dominios:* Trabajo = 9/10; Vida Social = 9/10; Vida Familiar = 8/10.
- **Pérdida de Productividad:** 3 días de ausentismo total y 4 días improductivos en la última semana. **Intervención Clínica:** Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición Interoceptiva y en Vivo graduada, combinada con Sertralina (100 mg/día). Se involucró a la pareja para extinguir conductas de reaseguro y acomodación.

Reevaluación a las 12 Semanas: La Puntuación Total SDI descendió a **3 / 30 puntos (Sin Discapacidad Significativa)**. Trabajo = 1/10; Vida Social = 1/10; Vida Familiar = 1/10; Días perdidos = 0. El paciente volvió a desplazarse en metro y reasumió la modalidad laboral presencial sin crisis.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO DE INVALIDEZ PERMANENTE:

Un SDI laboral ≥ 8 sostenido por más de 6 meses cuadruplica el riesgo de incapacidad laboral permanente; intervenir de forma intensiva y precoz.

DISCAPACIDAD VS. SOMATIZACIÓN:

En dolor crónico o fibromialgia, la interferencia no siempre correlaciona con daño tisular sino con catastrofismo y miedo al movimiento (kinesiofobia).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Sheehan, D. V., Harnett-Sheehan, K., & Raj, B. A. (1996). The measurement of disability: The Sheehan Disability Scale. *European Psychiatry*, 11(Suppl 4), 89s-95s.
2. Bobes, J., González, M. P., Bousoño, M., et al. (1999). Propiedades psicométricas de la versión española del Inventario de Discapacidad de Sheehan en pacientes con depresión y ansiedad. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 27(4), 241-248.
3. Leon, A. C., Olfson, M., Portera, L., et al. (1997). Assessing psychiatric impairment in primary care with the Sheehan Disability Scale. *International Journal of Psychiatry in Medicine*, 27(2), 93-105.
4. Sheehan, K. H., & Sheehan, D. V. (2008). Assessing treatment effects in clinical trials with the Disconnected Sheehan Disability Scale. *International Clinical Psychopharmacology*, 23(2), 70-83.